1. Objetivo:

Garantir administração de medicação conforme protocolo de segurança do paciente - Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos.

2. Responsável:

Equipe de enfermagem.

3. Material Necessário:

- Bandeja, rótulo de identificação;
- Luvas de procedimento;
- Diluente do medicamento (se necessário);
- Agulha 40x12 (Preparo do medicamento);
- Agulha 25 x 0,8 mm ou 30 x 0,8 mm (administração);
- Seringa;
- Medicamento prescrito;
- Cateter agulhado (scalp) ou cateter sobre agulha (abocath);
- Algodão;
- Clorexidina alcoólica ou álcool 70%.
- Garrote;
- Esparadrapo/micropore.

4. Descrição da Atividade:

- Realizar higienização das mãos;
- Conferir a prescrição (data, nome do medicamento, nome do usuário, via de administração, dose, horário e histórico de alergias);
- Fazer a etiqueta de identificação;
- Reunir o material necessário;
- Conferir o nome do medicamento, dose, via e prazo de validade;
- Separar o frasco ou a ampola e fazer a limpeza com algodão embebido em álcool a 70%, antes de puncionar o frasco ou quebrar a ampola;
- Abrir a embalagem da seringa e acoplá-la à agulha para aspiração do medicamento, observando-se a técnica asséptica;
- Se necessário, dilua o medicamento para obter a dose prescrita.
- Colocar a seringa na posição vertical e retirar o ar, se terapia endovenosa, retirar o ar do equipo;
- Trocar a agulha de aspiração pela agulha que será administrada a medicação;
- Explicar ao usuário e/ou acompanhante o procedimento e informar o medicamento a ser administrado;
- Posicionar o paciente de maneira confortável e adequada;
- Certificar-se sobre a possibilidade de alergia de material, medicamento ou produto;
- Expor a região a ser puncionada;
- Palpar a rede venosa para escolher o local a ser puncionado, de preferência vasos periféricos superficiais de grosso calibre;
- Escolher o cateter adequado ao calibre do vaso periférico;
- Prender o garrote acima do local escolhido (não o colocar sobre as articulações);
- Pedir ao usuário para abrir e fechar a mão duas ou três vezes e, em seguida, mantê-la fechada;

- Calçar as luvas;
- Fazer a antissepsia da área usando algodão embebido em álcool 70%, com movimentos no sentido do retorno venoso;
- Tracionar a pele (no sentido da porção distal do membro) com a mão não dominante, posicionando o dedo polegar cerca de 2,5cm abaixo do local selecionado para a punção;
- Inserir a agulha com o bisel voltado para cima, até observar o refluxo do sangue;
- Soltar o garrote e solicitar ao cliente para abrir a mão;
- Retirar o mandril quando puncionar com cateter sobre agulha, fazendo pressão acima da ponta do cateter com o indicador da mão não dominante; Se puncionar com seringa e agulha, aspirar para testar refluxo de sangue e administrar lentamente a medicação, sempre testando se a agulha permanece no vaso sanguíneo;
- Fixar o cateter à pele do usuário, utilizando micropore e/ou esparadrapo;
- Conectar a seringa ou equipo no cateter;
- Administrar a medicação;
- Recolher o material utilizado, desprezar o lixo em local adequado;
- Retirar as luvas de procedimento;
- Higienizar as mãos;
- Realizar registro no prontuário, carimbar e assinar;
- Fazer anotação de enfermagem se houver intercorrências.

Observações:

- Nunca realizar o reencape de agulha e/ou cateter.
- Nos casos de frasco ampola retirar a proteção metálica com o auxílio de uma tesoura e após, fazer a desinfecção.
- Caso haja dificuldade de visualização da veia, é indicado retirar o garrote e pedir ao cliente para abrir e fechar a mão várias vezes com o braço em posição

pendente (para baixo) para aumentar o fluxo venoso, indica-se também, colocar bolsa de água morna sobre a região de punção para promover vasodilatação e facilitar a visualização das veias.

- Se houver insucesso em duas tentativas de punção venosa, chamar outro profissional da enfermagem para proceder a nova punção;
- Contra indicações para punção venosa relacionadas ao local de punção: mastectomia; fístula arteriovenosa, linfedema, déficit motor e sensitivo, locais com lesões cutâneas.

Controle de revisões			
Rev.	**Data**	**Revisão efetuada**	**Responsável**
00	27/04/2026	Emissão inicial	Lana Carolina

Elaboração	*Análise Crítica e Aprovação*
Nome: Lana Carolina **Data:** 27/04/2026	**Nome:** Dr Ary Leite **Data:**